	ID & Name der Hauptkategorie	Name der Unterkategorie	Inhalt der Anforderung	Klassifikation	ID der Quelle (WAAD-Knoten)	Begründung für die Anforderung	Bemerkung zur Anforderung
▼ ID 1: Patientenaufnahme & Terminmanagement – Rezeption							
▼ ID 1.1: Stammdatenerfassung							
	ID 1: Patientenaufnahme & Terminmanagement – Rezeption	ID 1.1: Stammdatenerfassung	Das System MUSS ein klar strukturiertes, responsives Interface bereitstellen, das eine schnelle, fehlerarme Erfassung von Stammdaten (Name, Geburtsdatum, Versicherung etc.) ermöglicht. Pflichtfelder müssen visuell hervorgehoben und validiert sein.	MUST . Funktional	ID 1.1.1	Basisfunktion für Patientenaufnahme; Reduktion von Eingabefehlern	
▼ ID 1.2: Terminverwaltung & Erstkontakt-Organisation							
	ID 1: Patientenaufnahme & Terminmanagement – Rezeption	ID 1.2: Terminverwaltung & Erstkontakt-Organisation	Das System MUSS Funktionen zum Anlegen, Verschieben und Löschen von Terminen bieten, inkl. Konfliktprüfung und visuellem Kalender. Termine müssen farblich unterscheidbar sein (z. B. Art der Behandlung).	MUST . Funktional	ID 1.2.1	Zentrale Funktion im Patientenkontakt, Voraussetzung für Praxisorganisation	
	ID 1: Patientenaufnahme & Terminmanagement – Rezeption	ID 1.2: Terminverwaltung & Erstkontakt-Organisation	Das System MUSS die Möglichkeit bieten, Sofort- oder Notfalltermine („Heute“/„Jetzt“) mit Priorisierung direkt einzugeben. Diese Termine müssen klar gekennzeichnet sein.	MUST . Funktional	ID 1.2.2	Wichtig bei spontanen Patientenkontakten oder medizinischen Notfällen	
	ID 1: Patientenaufnahme & Terminmanagement – Rezeption	ID 1.2: Terminverwaltung & Erstkontakt-Organisation	Das System SOLL ermöglichen, Termine über längere Zeiträume hinweg zu planen (z. B. in der nächsten Woche oder Monat).	SHOULD . Funktional	ID 1.2.3	Entlastung bei nicht-akuten Fällen, bessere langfristige Planung	Eine Erinnerungsfunktion (z. B. per SMS oder E-Mail) SOLL optional verfügbar sein, um Patienten an Termine zu erinnern.
	ID 1: Patientenaufnahme & Terminmanagement – Rezeption	ID 1.2: Terminverwaltung & Erstkontakt-Organisation	Bei Terminänderungen MUSS das System automatisch eine Benachrichtigung generieren und neue Vorschläge anbieten.	MUST . Funktional	ID 1.2.4	Vermeidung von Missverständnissen und Terminausfällen	Diese Funktion DARF optional an Patientenkommunikation angebunden sein (z. B. E-Mail/ SMS).
▼ ID 1.3: Rollenlogik							
	ID 1: Patientenaufnahme & Terminmanagement – Rezeption	ID 1.3: Rollenlogik	Das System SOLL eine strukturierte Weiterleitungsfunktion zur ärztlichen Akte anbieten, inkl. Auswahloptionen in Listenform (z. B. 'Akte an Arzt weiterleiten').	SHOULD . Funktional	ID 1.3.1	Ermöglicht klare und fehlerarme Kommunikation zwischen Rezeption und Arzt	Die Form der Datenweitergabe (z. B. Dropdown, Liste) SOLL flexibel definierbar sein. Eine Mehrfachauswahl für Empfänger:innen SOLLTE unterstützt werden.
	ID 1: Patientenaufnahme & Terminmanagement – Rezeption	ID 1.3: Rollenlogik	Das System MUSS eine rollenbasierte Zugriffskontrolle implementieren, bei der die Rezeption standardmäßig keinen Zugriff auf medizinische Inhalte hat. Zugriffsrechte müssen vom Arzt individuell vergeben werden können.	MUST . Nicht-Funktional (Sicherheit)	ID 1.3.2	Datenschutz & klare Zuständigkeiten	
	ID 1: Patientenaufnahme & Terminmanagement – Rezeption	ID 1.3: Rollenlogik	Das System SOLL dem Arzt eine vollständige, filterbare Übersicht aller Termine bereitstellen.	SHOULD . Funktional	ID 1.3.3	Transparenz im Praxisablauf und bessere Organisation	(z. B. nach Tag, Patient, Raum).
▼ ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle							
▼ ID 2.1: Zugriffsverwaltung							
	ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle	ID 2.1: Zugriffsverwaltung	Das System MUSS eine Benutzerhierarchie implementieren, in der die Rolle 'Rezeption' standardmäßig keinen Zugriff auf vollständige Patientendaten hat. Nur der Arzt darf explizit und gezielt Lesezugriff auf bestimmte Aktenbereiche gewähren oder entziehen.	MUST – Nicht-Funktional (Sicherheit)	ID 2.1.1	Schutz sensibler Daten, klare Rollentrennung	Zugriffsrechte SOLLEN vom Arzt individuell konfigurierbar sein – differenziert nach Akteninhalt oder Patientengruppe.
	ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle	ID 2.1: Zugriffsverwaltung	Die Rezeption darf keine medizinischen Informationen eingeben oder bearbeiten. Das System MUSS dies durch rollenbasierte Schreibrechte technisch absichern.	MUST – Nicht-Funktional (Sicherheit)	ID 2.1.2	Vermeidung fachlicher Fehler, rechtliche Absicherung	Die Einschränkung von Schreibrechten SOLL durch den Arzt für ausgewählte Kontexte einstellbar sein (z. B. bestimmte Datenbereiche).
	ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle	ID 2.1: Zugriffsverwaltung	Nur der Arzt darf medizinische Inhalte wie Diagnosen, Behandlungen oder Verläufe erstellen und verändern. Das System MUSS dies rollenbasiert absichern.	MUST – Nicht-Funktional (Sicherheit)	ID 2.1.3	Sicherstellung der medizinischen Verantwortung	Diese Funktion SOLL vom Arzt aktivierbar sein (parametrierbar), z. B. für bestimmte Patienten oder Datentypen.
	ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle	ID 2.1: Zugriffsverwaltung	Im Standardzustand SOLL die Sichtbarkeit von Akten für die Rezeption aktiviert sein (nur lesend), es sei denn, der Arzt deaktiviert dies ausdrücklich.	SHOULD – Nicht-Funktional (Sicherheit)	ID 2.1.4	Effizienz im Ablauf bei gleichzeitiger Kontrolle durch den Arzt	Diese Funktion SOLL vom Arzt aktivierbar sein (parametrierbar), z. B. für bestimmte Patienten oder Datentypen.
▼ ID 2.2: Rollenlogik							
	ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle	ID 2.2: Rollenlogik	Das System MUSS ein Interface zur Validierung von Akten anzeigen, in dem alle noch zu prüfenden Einträge für den Arzt sichtbar sind (z. B. zur täglichen Kontrolle).	MUST – Funktional	ID 2.2.1	Fehlerkontrolle und rechtssichere Dokumentation	
	ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle	ID 2.2: Rollenlogik	Alle Akteneinträge MÜSSEN durch den Arzt validiert und erst danach in der Datenbank final gespeichert werden.	MUST – Funktional	ID 2.2.2	Medizinische und rechtliche Verantwortung liegt beim Arzt	
	ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle	ID 2.2: Rollenlogik	Das System SOLL optional ermöglichen, dass ausschließlich der Arzt medizinische Inhalte verwalten soll, einschließlich Ergänzungen und Änderungen (Sicherheitspräferenz).	SHOULD – Nicht-Funktional (Sicherheit)	ID 2.2.3	Erhöhte Kontrolle und Datensicherheit	Ein zentrales Interface zur Rechtevergabe MUSS technisch realisiert und im System integriert sein.
	ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle	ID 2.2: Rollenlogik	Der Arzt MUSS über eine zentrale Oberfläche individuelle Berechtigungen an andere Rollen vergeben oder entziehen können.	MUST – Funktional	ID 2.2.4	Transparente Rollensteuerung und Verantwortungsklarheit	
	ID 2: Rechte- und Zugriffskontrolle	ID 2.2: Rollenlogik	Das System SOLL ein interaktives Dashboard für Ärzte bereitstellen, das Überblick über Termine, Befunde, Dokumentationen und Freigaben bietet.	SHOULD – Funktional	ID 2.2.5	Erhöht Effizienz und minimiert Navigationsaufwand in stressigen Situationen.	Das System SOLL die Funktionen'Daten ergänzen' und 'Daten ändern' zu verfügung stellen und basiert auf Berechtigungen Umsetzung basieren.
▼ ID 3: Ärztliche Behandlung & Dokumentation – Arzt							
▼ ID 3.1: Diagnose, Behandlung, Verlauf							

	ID & Name der Hauptkategorie	Name der Unterkategorie	Inhalt der Anforderung	Klassifikation	ID der Quelle (WAAD-Knoten)	Begründung für die Anforderung	Bemerkung zur Anforderung
	ID 3: Ärztliche Behandlung & Dokumentation – Arzt	ID 3.1: Diagnose, Behandlung, Verlauf	Das System MUSS ein klares, intuitives Interface zur strukturierten Erfassung medizinischer Informationen bieten. Dazu zählen Diagnose, Behandlungsschritte, Verlauf und ärztliche Anweisungen.	MUST – Funktional	ID 3.1.1	Ermöglicht vollständige und nachvollziehbare medizinische Dokumentation	Die Eingabemaske MUSS Eingabehilfen (z. B. Auswahlfelder, Validierung) enthalten.
	ID 3: Ärztliche Behandlung & Dokumentation – Arzt	ID 3.1: Diagnose, Behandlung, Verlauf	Das System SOLL ermöglichen, Diagnosen, Atteste und Rezepte effizient zu erstellen und direkt in der Patientenakte zu speichern.	SHOULD – Funktional	ID 3.1.2	Zeitersparnis, Standardisierung, Reduktion von Fehlern	Optional soll ein Schnellzugriff auf häufig genutzte Vorlagen und ein visuelles Modell (z. B. 2D-Anatomie) integriert werden.
	ID 3: Ärztliche Behandlung & Dokumentation – Arzt	ID 3.1: Diagnose, Behandlung, Verlauf	Das System MUSS erlauben, medizinische Einträge nachträglich zu ergänzen oder zu aktualisieren.	MUST – Funktional	ID 3.1.3	Sichert Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Patientenakte	Dabei medizinische Inhalte versioniert speichern und Änderungen mit Zeitstempel und Benutzerkennung nachvollziehbar dokumentiert werden.
	ID 3: Ärztliche Behandlung & Dokumentation – Arzt	ID 3.1: Diagnose, Behandlung, Verlauf	Das System MUSS ermöglichen, medizinische Anhänge (z. B. Röntgenbilder, Laborberichte, externe PDFs) mit Dokumenttyp, Referenznummer und optionalen Tags in strukturierter Form zu speichern.	MUST – Funktional	ID 3.1.4	Vollständige Dokumentation medizinischer Daten mit schneller Wiederauffindbarkeit	
▼ ID 4: Patientenakte & Archivierung							
▼ ID 4.1: Vollständigkeit							
	ID 4: Patientenakte & Archivierung	ID 4.1: Vollständigkeit	Das System MUSS ein Eingabefeld für zusätzliche Verwaltungsdaten bieten, wie z. B. Versicherungsnummer, Zugehörigkeit zu Versicherungsträgern oder Besonderheiten. Die Informationen MÜSSEN sicher in der Akte gespeichert werden.	MUST – Funktional	ID 4.1.1	Vollständige, nachvollziehbare Patientendaten für Abrechnung und Nachverfolgung	
	ID 4: Patientenakte & Archivierung	ID 4.1: Vollständigkeit	Das System SOLL es ermöglichen, Atteste, Rezepte und zusätzliche Dokumente zu erstellen und automatisch in der Patientenakte zu archivieren.	SHOULD – Funktional	ID 4.1.2	Reduktion von Papierdokumenten, effizientere Nachvollziehbarkeit	
	ID 4: Patientenakte & Archivierung	ID 4.1: Vollständigkeit	Für physische Dokumente MUSS das System die Möglichkeit bieten, Dokumenttyp und eindeutige ID zu erfassen und zu speichern. Ein Such- oder Filtermechanismus muss die Wiederauffindbarkeit unterstützen.	MUST – Funktional	ID 4.1.3	Strukturierte Archivierung externer Dokumente, schnelles Wiederfinden	Dient als Übergangslösung für papierbasierte Praxen – erleichtert Umstieg auf digitale Archivierung.
	ID 4: Patientenakte & Archivierung	ID 4.1: Vollständigkeit	Das System MUSS Belegnummern (z. B. von Quittungen, Rechnungen, Rezepten) in der Patientenakte erfassen und zuordnen können, optional auch als Scan.	MUST – Funktional	ID 4.1.4	Erleichtert Kostenerstattung, Abrechnung und Kontrolle	Gedacht für Einrichtungen, die mit Papierbelegen arbeiten – erleichtert den Einstieg in digitale Dokumentation und Belegverfolgung.
▼ ID 4.2: Ordnung medizinischer Daten							
	ID 4: Patientenakte & Archivierung	ID 4.2: Ordnung medizinischer Daten	Das System SOLL eine verständliche, konsistente Benutzeroberfläche für die Eingabe und Anzeige medizinischer Daten bieten. Alle Informationen SOLLEN jederzeit nachvollziehbar und versioniert sein.	SHOULD – Funktional	ID 4.2.1	Effizientes Arbeiten und Fehlervermeidung durch Klarheit	
	ID 4: Patientenakte & Archivierung	ID 4.2: Ordnung medizinischer Daten	Das System MUSS über eine intelligente Suchfunktion verfügen, die auch bei Namensähnlichkeiten oder Teilsuchen zuverlässige Ergebnisse liefert.	MUST – Funktional	ID 4.2.2	Fehlerminimierung bei Auswahl ähnlicher Patientendatensätze	(z. B. Auto-Vervollständigung, phonemische Ähnlichkeit).
▼ ID 5: Nachsorge & Kommunikation – Rezeption & Arzt							
▼ ID 5.1: Weitergabe wichtiger Infos							
	ID 5: Nachsorge & Kommunikation – Rezeption & Arzt	ID 5.1: Weitergabe wichtiger Infos	Das System DARF ermöglichen, dass ärztlich relevante Informationen zur Weiterbehandlung (z. B. Medikation, Kontrolltermin, Facharztüberweisung) am Ende der Behandlung für Patient:innen zusammengefasst und übergeben werden können.	NICE TO HAVE – Funktional	ID 5.1.1	Sichert den Behandlungserfolg durch klare Weitergabe wichtiger Informationen	
	ID 5: Nachsorge & Kommunikation – Rezeption & Arzt	ID 5.1: Weitergabe wichtiger Infos	Die Kommunikation zwischen Rezeption und Arzt DARF auf ein funktional erforderliches Minimum reduziert werden können, z. B. durch automatisierte Freigaben, Hinweise oder digitale Weiterleitungen.	NICE TO HAVE – Nicht-Funktional (Effizienz)	ID 5.1.2	Reduziert Zeitaufwand und Fehlerpotenzial durch ständige Rückfragen	
▼ ID 5.2: Patientenkommunikation							
	ID 5: Nachsorge & Kommunikation – Rezeption & Arzt	ID 5.2: Patientenkommunikation	Die Rezeption MUSS Patient:innen über verordnete Medikamente, Kontrolltermine oder Folgeschritte informieren können, basierend auf vom Arzt freigegebenen Informationen.	MUST – Funktional	ID 5.2.1	Unterstützt Patientencompliance und sichert Nachsorge	Das System SOLL durch strukturierte Filter oder Entscheidungslogik Vorschläge machen, wann Anliegen weitergeleitet werden müssen.
	ID 5: Nachsorge & Kommunikation – Rezeption & Arzt	ID 5.2: Patientenkommunikation	Rückfragen DARF über ein Ticket- oder Notizsystem dokumentiert und automatisch der verantwortlichen ärztlichen Person zugeordnet werden.	NICE TO HAVE – Funktional	ID 5.2.2	Sichert Kommunikation und Nachvollziehbarkeit im Behandlungsverlauf	
	ID 5: Nachsorge & Kommunikation – Rezeption & Arzt	ID 5.2: Patientenkommunikation	Das System MUSS es ermöglichen, Ausdrucke oder digitale Dokumente (z. B. PDFs) direkt aus der Patientenakte zu generieren und für Patient:innen bereitzustellen.	MUST – Funktional	ID 5.2.3	Vollständige Informationsweitergabe für Patient:innen	
▼ ID 6: Leistungen, Kostenmanagement – Rezeption & Arzt							
▼ ID 6.1: Finanzverwaltung & Dokumentation							
	ID 6: Leistungen, Kostenmanagement – Rezeption & Arzt	ID 6.1: Finanzverwaltung & Dokumentation	Die Rezeption MUSS sämtliche Einnahmen dokumentieren können (bar). Das System MUSS Eingabehilfen, Validierung (z. B. Betragsfelder) und Tagesabschlussübersichten bieten.	MUST – Funktional	ID 6.1.1	Grundlage für Kassensturz, Buchhaltung und Steuerabwicklung	

	ID & Name der Hauptkategorie	Name der Unterkategorie	Inhalt der Anforderung	Klassifikation	ID der Quelle (WAAD-Knoten)	Begründung für die Anforderung	Bemerkung zur Anforderung
	ID 6: Leistungen, Kostenmanagement – Rezeption & Arzt	ID 6.1: Finanzverwaltung & Dokumentation	Kostenpflichtige Leistungen MÜSSEN im System vom Arzt freigegeben werden, bevor sie verrechnet oder dokumentiert werden dürfen. Extra : Die Betrage DÜRFEN vorher definiert sein, um den Betrag Freigabeprozess zu automatisieren.	MUST – Funktional	ID 6.1.2	Medizinisch-inhaltliche Kontrolle über abrechenbare Leistungen	
	ID 6: Leistungen, Kostenmanagement – Rezeption & Arzt	ID 6.1: Finanzverwaltung & Dokumentation	Das System SOLL eine Funktion zur strukturierten Verwaltung von Erstattungsbelegen bieten. Belege müssen parametrisch filterbar seinund zugeordnet werden können.	SHOULD – Funktional	ID 6.1.3	Erleichtert Verwaltung, Kontrolle und Rückverfolgung von Ausgaben	(z. B. nach Datum, Betrag, Kategorie).
	ID 6: Leistungen, Kostenmanagement – Rezeption & Arzt	ID 6.1: Finanzverwaltung & Dokumentation	Das System SOLL eine Einkaufsübersicht bereitstellen, die alle Artikel und deren Zustände auflistet.	SHOULD – Funktional	ID 6.1.4	Ermöglicht Bestandskontrolle, Nachbestellung und Rückverfolgbarkeit	Wie (z. B. Menge, Lagerort, Lieferdatum…)
▼ ID 6.2: Kontrolle							
	ID 6: Leistungen, Kostenmanagement – Rezeption & Arzt	ID 6.2: Kontrolle	Das System MUSS eine Übersicht über sämtliche Ausgaben, Einnahmen, Gewinne und Verluste bieten. Diese Übersicht SOLL nach Zeiträumen filterbar und exportierbar sein.	MUST – Funktional	ID 6.2.1	Transparenz und Kontrolle für Praxisführung und Steuerberatung	
	ID 6: Leistungen, Kostenmanagement – Rezeption & Arzt	ID 6.2: Kontrolle	Das System MUSS automatisch Statistiken über Leistungen, Einnahmen, Kosten und Erstattungen generieren können.	MUST – Funktional	ID 6.2.2	Erleichtert wirtschaftliche Analyse, Abrechnung, Planung	(z. B. Balkendiagramm nach Monat, pro Arzt oder pro Leistung).
	ID 6: Leistungen, Kostenmanagement – Rezeption & Arzt	ID 6.2: Kontrolle	Das System MUSS Ausdrucke oder PDF-Exporte aller Umsätze für die Steueranmeldung bereitstellen.	MUST – Funktional	ID 6.2.3	Pflicht für Steuerprüfung, Buchhaltung und Archiv	
	ID 6: Leistungen, Kostenmanagement – Rezeption & Arzt	ID 6.2: Kontrolle	Die Rezeption DARF Zugriff auf aktuelle Preislisten haben; der Arzt MUSS die jeweils erbrachten Leistungen digital bestätigen.	NICE TO HAVE – Funktional	ID 6.2.4	Fehlerreduktion und klare Verantwortlichkeit bei der Abrechnung	
▼ ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung							
▼ ID 7.1: Effizienz, Vorlagen, UI-Hilfen							
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.1: Effizienz, Vorlagen, UI-Hilfen	Das System SOLL vordefinierte Attest- und Rezeptvorlagen bereitstellen, die individuell angepasst und schnell ausgewählt werden können.	SHOULD – Funktional	ID 7.1.1	Reduziert Dokumentationsaufwand und verhindert Wiederholfehler	
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.1: Effizienz, Vorlagen, UI-Hilfen	Das System MUSS Optionslisten für Leistungen, Medikamente und Untersuchungen bereithalten, die kontextabhängig angezeigt und gefiltert werden können.	MUST – Funktional	ID 7.1.2	Vermeidet Eingabefehler, beschleunigt Auswahlprozesse	
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.1: Effizienz, Vorlagen, UI-Hilfen	Das System SOLL strukturierte Formulare mit Pflichtfeldern, Plausibilitätsprüfungen und Eingabehilfen nutzen, um den Schreibaufwand zu minimieren.	SHOULD – Funktional	ID 7.1.3	Reduziert Zeitaufwand und Fehlerquote in der täglichen Praxis	Bei der Eingabe medizinischer Daten standardisierte Textbausteine und Auswahlhilfen vorschlagen.
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.1: Effizienz, Vorlagen, UI-Hilfen	Das System MUSS eine parametrische Filterfunktion zur schnellen Suche nach Informationen in der Akte, Leistungen oder Kostenübersicht enthalten.	MUST – Funktional	ID 7.1.4	Verbessert Navigation und reduziert Suchzeit	
▼ ID 7.2: Schulung & Einstieg							
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.2: Schulung & Einstieg	Die Einarbeitungszeit in das System DARF bei maximal 1–2 Monaten liegen, inkl. schrittweiser Übergabe von Funktionen. Hilfetexte, Tooltips und Tutorials SOLLTEN integriert sein.	NICE TO HAVE – Nicht-Funktional (Usability)	ID 7.2.1	Schneller Einstieg, weniger Schulungsaufwand für neues Personal	
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.2: Schulung & Einstieg	Online-Schulungen DÜRFEN angeboten werden, da zeitlich flexible Formate notwendig sind.	NICE TO HAVE – Nicht-Funktional (Usability)	ID 7.2.2	Berücksichtigung zeitlicher Belastung im Praxisalltag	
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.2: Schulung & Einstieg	Das System DÜRFEN durch „Learning-by-Doing"-Elemente vor Ort erlernbar sein.	NICE TO HAVE – Nicht-Funktional (Usability)	ID 7.2.3	Praktischer Wissenserwerb im Anwendungskontext	z. B. durch schrittweise Einblendung relevanter Funktionen.
▼ ID 7.3: Fehleranfälligkeit, Korrekturmöglichkeiten							
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.3: Fehleranfälligkeit, Korrekturmöglichkeiten	Das System MUSS die Fehleranfälligkeit der Dateneingabe verringern, z. B. durch Pflichtfelder, Autovervollständigung und Validierungsregeln. Besonders im Bereich der Rezeption liegt die Fehlerquote aktuell bei ca. 10 %.	MUST – Nicht-Funktional (Zuverlässigkeit)	ID 7.3.1	Minimierung typischer Eingabefehler bei hoher Belastung	Die Autovervollständigung MUSS deaktivierbar sein und sich ausschließlich auf eine vorbereitete, validierte Namensliste stützen. Die Option zur Deaktivierung SOLL benutzerindividuell konfigurierbar sein.
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.3: Fehleranfälligkeit, Korrekturmöglichkeiten	Das System SOLL Korrekturen durch den Arzt ermöglichen.	SHOULD – Funktional	ID 7.3.2	Ermöglicht Korrektursicherheit durch medizinisches Fachpersonal	z. B. über ein Bearbeitungsprotokoll oder Änderungsverlauf.
	ID 7: Standardisierung, Zeitersparnis & Fehlervermeidung	ID 7.3: Fehleranfälligkeit, Korrekturmöglichkeiten	Das System DARF eine Funktion zur Fehlersuche enthalten, etwa durch Markierung unvollständiger Einträge oder Versionsvergleiche, da Fehler sonst unbemerkt bleiben können.	NICE TO HAVE – Funktional	ID 7.3.3	Steigerung der Datenqualität durch nachvollziehbare Kontrolle	Für das Fehlersuch-Subsystem MUSS eine Durchführbarkeitsanalyse erfolgen, um Komplexität, Performance und Integration in bestehende Strukturen bewerten zu können.
▼ ID 8: Design & UI-Wünsche							
▼ ID 8.1: Benutzeroberfläche & Navigation							
	ID 8: Design & UI-Wünsche	ID 8.1: Benutzeroberfläche & Navigation	Das Design MUSS klar, übersichtlich und funktional sein. Optische Gestaltung ist zweitrangig, entscheidend sind einfache Navigation und gute Lesbarkeit – auch bei langen Arbeitstagen.	MUST – Nicht-Funktional (Usability)	ID 8.1.1	Effektive und fehlerfreie Nutzung im stressigen Praxisalltag	
	ID 8: Design & UI-Wünsche	ID 8.1: Benutzeroberfläche & Navigation	Die Benutzeroberfläche MUSS eine strukturierte Darstellung bieten, in der sich ähnlich klingende Patienten oder Daten gut unterscheiden lassen.	MUST – Nicht-Funktional (Usability)	ID 8.1.2	Fehlervermeidung bei der Auswahl von Patienten mit ähnlichen Namen	(z. B. durch Hervorhebungen oder zusätzliche Attribute wie Geburtsdatum).

	ID & Name der Hauptkategorie	Name der Unterkategorie	Inhalt der Anforderung	Klassifikation	ID der Quelle (WAAD-Knoten)	Begründung für die Anforderung	Bemerkung zur Anforderung
	ID 8: Design & UI-Wünsche	ID 8.1: Benutzeroberfläche & Navigation	Das System DARF ein modernes, visuell klar strukturiertes Design besitzen, um die Orientierung zu erleichtern.	SHOULD – Nicht-Funktional (UI)	ID 8.1.3	Fördert schnelle Einarbeitung und Akzeptanz bei digital unerfahrenen Nutzer:innen	inspiriert von vertrauten Plattformen (z. B. Instagram)
	ID 8: Design & UI-Wünsche	ID 8.1: Benutzeroberfläche & Navigation	Die Oberfläche DARF eine zentrale Preisübersicht, einen Behandlungskatalog und eine flexible Suchfunktion bieten, die nach Bezeichnung, Kategorie oder Preis filterbar ist.	NICE TO HAVE – Funktional	ID 8.1.4	Schneller Zugriff auf entscheidungsrelevante Informationen während der Behandlung	Das finale UI-Design SOLL auf Basis von Gebrauchstauglichkeitskriterien und Nutzerfeedback iterativ festgelegt werden.
▼ ID 9: Systemtechnische Sonderfunktionen							
▼ -							
	ID 9: Systemtechnische Sonderfunktionen	-	Das System MUSS täglich automatisch eine Sicherungskopie aller Daten erstellen – lokal, extern und optional cloudbasiert. Die Backups MÜSSEN verschlüsselt sein und eine Wiederherstellungsfunktion bieten.	MUST – Nicht-Funktional (Sicherheit)	ID 9.1	Datensicherheit bei Systemausfall oder Hardwaredefekt	Die Backup-Funktion MUSS so gestaltet sein, dass Speicherverbrauch und -verwaltung skalierbar und überprüfbar bleiben.
	ID 9: Systemtechnische Sonderfunktionen	-	Das System MUSS eine zentrale, einheitliche Benutzeroberfläche („Dashboard“) für alle ärztlichen Kernaufgaben bereitstellen, z. B. Akteneinsicht, Freigaben, Dokumentation, Kommunikation und Statistik.	MUST – Funktional	ID 9.2	Erhöht Übersichtlichkeit, reduziert Klickpfade und Fehler	
	ID 9: Systemtechnische Sonderfunktionen	-	Das System DARF eine Cloud-Anbindung unterstützen, um bei lokalen Ausfällen weiterarbeiten zu können. Die Cloud-Speicherung MUSS DSGVO-konform erfolgen.	NICE TO HAVE – Nicht-Funktional (Verfügbarkeit)	ID 9.3	Betriebssicherheit bei Hardwareausfällen, Mobilität	
	ID 9: Systemtechnische Sonderfunktionen	-	Das System DARF keine spürbaren Verzögerungen bei der Bedienung verursachen. Ladezeiten MÜSSEN < 2 Sekunden betragen, sonst wird die Nutzung als ineffizient bewertet.	NICE TO HAVE – Nicht-Funktional (Performance)	ID 9.4	Schnelle Reaktionszeiten sichern Akzeptanz und Effizienz	Systemladezeiten SOLLEN regelmäßig per Stresstest geprüft und dokumentiert werden, um Performanceziele zu validieren.
	ID 9: Systemtechnische Sonderfunktionen	-	Das System SOLL eine Statistikübersicht zu Krankheitsbildern, Verlaufsmustern und Behandlungsergebnissen enthalten, optional mit Exportmöglichkeit für Auswertungen.	SHOULD – Funktional	ID 9.5	Unterstützt Praxissteuerung, Forschung und Qualitätskontrolle	